

คู่มือการใช้งาน
ระบบคัดกรองสุขภาพจิต

สำหรับ อสม. เจ้าหน้าที่ Admin และโรงพยาบาล

ชื่อไฟล์: คู่มือระบบคัดกรองสุขภาพจิต ฉบับอัปเดต มิถุนายน ๒๕๖๕

แนวทางการอ่านคู่มือนี้

คู่มือนี้เขียนแบบสั้น เข้าใจง่าย และใช้คำทั่วไป

ทำตามทีละขั้นตอนจากภาพประกอบได้ทันที

คำว่า “เคส” หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่อยู่ในระบบ

ฉบับปรับปรุงตามหน้าจอสistemล่าสุด

วันที่ปรับปรุง: ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระบบคัดกรองสุขภาพจิต - รพ.สต.บ้านทองห...
https://mental-health-app-lovat.vercel.app

ระบบยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่

กรุณาเลือกประเภทผู้ใช้งานและกรอกรหัสผ่าน
ของคุณ

ประเภทผู้ใช้งาน *

อสม. (VHM)

Username

ระบุ Username ของคุณ

Password

ระบุ Password ของคุณ

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ตั้งรหัสใหม่ที่นี่

ภาพที่ 2: ตัวอย่างหน้าเข้าสู่ระบบ

สารบัญ

สารบัญนี้เพิ่มหัวข้อ Rich Menu ของ LINE OA และใส่เลขหน้าเพื่อเปิดอ่านได้ง่ายขึ้น

หัวข้อ	หน้า
ก่อนเริ่มใช้งาน: Rich Menu ของ LINE OA	3
บทที่ 1 ภาพรวมระบบและบทบาทผู้ใช้งาน	4
บทที่ 2 การเข้าสู่ระบบ	4
บทที่ 3 การคัดกรองโดย อสม.	7
บทที่ 4 การตรวจสอบและส่งข้อมูล	15
บทที่ 5 การติดตามในหมู่บ้านและร่างออฟไลน์	17
บทที่ 6 แดชบอร์ดผู้ดูแลข้อมูล	19
บทที่ 7 การดูข้อมูลผู้ป่วยและติดตามเคส	20
บทที่ 8 งานวันนี้ แจ้งเตือน และสรุปภาพรวม	29
บทที่ 9 จัดการเจ้าหน้าที่	37
บทที่ 10 คำปรึกษา Feedback และงานระบบ	40
บทที่ 11 การลบผู้ป่วย ถังขยะ และกู้คืนข้อมูล	50
บทที่ 12 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น	53

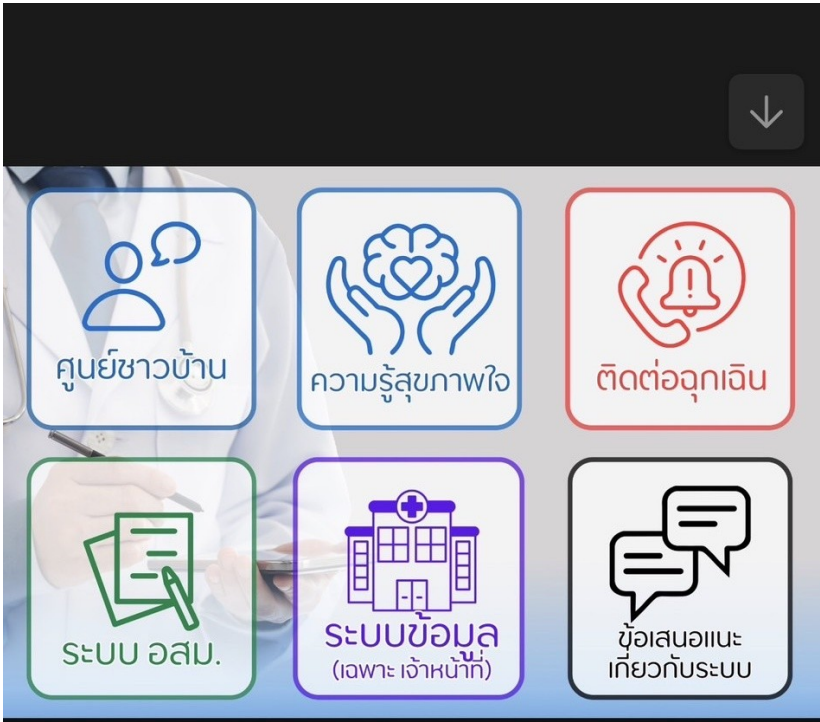
คำแนะนำ

สำหรับผู้เริ่มใช้ ให้เริ่มอ่านหัวข้อ Rich Menu และบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 ก่อน

สำหรับผู้ดูแลระบบ ให้เน้นบทที่ 6 ถึงบทที่ 11

ก่อนเริ่มใช้งาน: Rich Menu ของ LINE OA

เมื่อเปิด LINE OA จะเห็นเมนูหลักด้านล่างของหน้าจอ เมนูนี้เป็นทางเลือกสำหรับเข้าแต่ละส่วนของระบบ ผู้ใช้กดปุ่มที่ตรงกับงานของตนเองได้ทันที



ภาพ: Rich Menu ของ LINE OA ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าแต่ละส่วน

ปุ่มแต่ละปุ่มใช้ทำอะไร

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
ครอบครัวชาวบ้าน	เข้าไปดูส่วนบริการสำหรับชาวบ้าน เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการใช้งานทั่วไป
ความรู้สุขภาพใจ	อ่านความรู้ คำแนะนำ และสื่อดูแลสุขภาพใจเบื้องต้น
ติดต่อฉุกเฉิน	ใช้เมื่อมีเหตุเร่งด่วนหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร็ว
ระบบ อสม.	สำหรับ อสม. ใช้คัดกรอง บันทึกข้อมูล ดูร่างค่าง และส่งข้อมูลเข้าระบบ
ระบบข้อมูล (เฉพาะเจ้าหน้าที่)	สำหรับเจ้าหน้าที่ Admin และ Hospital ใช้ดูแดชบอร์ด จัดการผู้ป่วย ติดตามเคส ดูรายงาน และงานระบบ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ	ส่งความเห็น แจ้งปัญหา หรือเสนอสิ่งที่อยากให้ปรับปรุง โดยตั้งใจให้ส่งได้แบบไม่เปิดเผยตัวตน

จำง่าย ๆ
ชาวบ้านทั่วไปใช้ปุ่มด้านประชาชน ส่วนระบบ อสม. และระบบข้อมูล ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

บทที่ 1 ภาพรวมระบบและบทบาทผู้ใช้งาน

ระบบนี้ช่วยให้ อสม. และเจ้าหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิต ส่งข้อมูล และติดตามเคสในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบกลางเพื่อให้ทีมที่เกี่ยวข้องติดตามต่อได้

1.1 บทบาทผู้ใช้งาน

บทบาท	ทำอะไรได้บ้าง	หมายเหตุ
อสม. / VHV	คัดกรองใหม่ ดูรายชื่อในหมู่ ส่งข้อมูล และบันทึกร่าง	เหมาะสำหรับงานภาคสนาม
Admin	ดูแดชบอร์ด ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ติดตามงาน และจัดการข้อมูลทั่วไป	ใช้ติดตามงานระดับพื้นที่
Hospital	ทำได้เหมือนผู้ดูแล และมีสิทธิ์ขั้นสูง เช่น ลบผู้ป่วย จัดการเจ้าหน้าที่ และงานระบบ	ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

คำที่พบบ่อยในระบบ

SLA = กำหนดเวลาที่ควรติดตามเคส

Risk = ระดับความเสี่ยงของผู้ป่วย เช่น เขียว เหลือง แดง

Session = ประวัติการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่

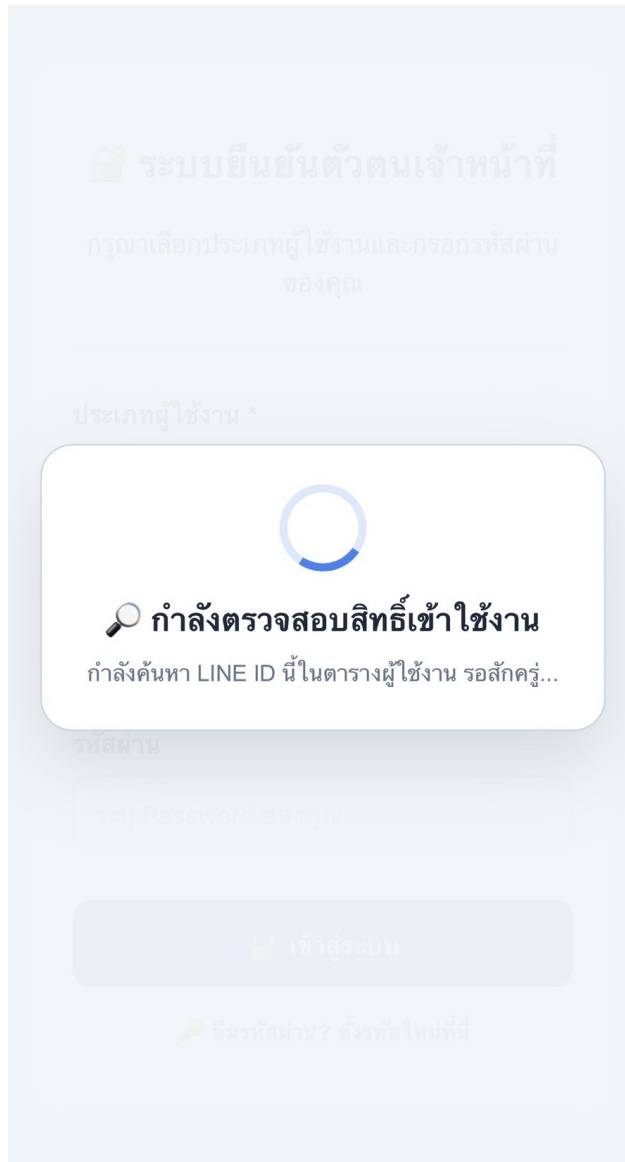
Staging = พื้นที่ทดสอบก่อนใช้จริง

Production = ระบบจริงที่ใช้งานจริง

บทที่ 2 การเข้าสู่ระบบ

2.1 การตรวจสอบสิทธิ์ด้วย LINE ID

เมื่อเปิดระบบใน LINE ระบบจะตรวจสอบก่อนว่า LINE ID นี้มีชื่ออยู่ในตารางผู้ใช้งานหรือไม่ ถ้าพบสิทธิ์แล้วจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบตามบทบาทที่เลือกได้



ภาพที่ 1: ระบบกำลังตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

2.2 เข้าสู่ระบบสำหรับ อสม.

- 1 . เลือกประเภทผู้ใช้งาน เช่น อสม. (VHV)
- 2 . กรอก Username และ Password
- 3 . กด “เข้าสู่ระบบ”
- 4 . ถ้าลืมรหัสผ่าน ให้กด “ลืมรหัสผ่าน? ตั้งรหัสใหม่ที่นี่”

ระบบคัดกรองสุขภาพจิต - รพ.สต.บ้านทองห...

https://mental-health-app-lovat.vercel.app

 ระบบยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่

กรุณาเลือกประเภทผู้ใช้งานและกรอกรหัสผ่าน
ของคุณ

ประเภทผู้ใช้งาน *

อสม. (VHM) 

Username

ระบุ Username ของคุณ

Password

ระบุ Password ของคุณ

 เข้าสู่ระบบ

 ลืมรหัสผ่าน? ตั้งรหัสใหม่ที่นี่

ภาพที่ 2: หน้าเข้าสู่ระบบของ อสม.

2.3 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลข้อมูล

ผู้ดูแลข้อมูลและโรงพยาบาลใช้หน้าเข้าสู่ระบบแดชบอร์ด โดยกรอก Username และ Password ของผู้ดูแล

ระบบยืนยันตัวตนผู้ดูแล

ข้อมูล (Admin)

กรุณกรอกสิทธิ์เข้าใช้งานเพื่อเข้าถึงระบบแดชบอร์ด

Username

ระบุ Username ผู้ดูแลระบบ

Password

ระบุ Password ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบแดชบอร์ด

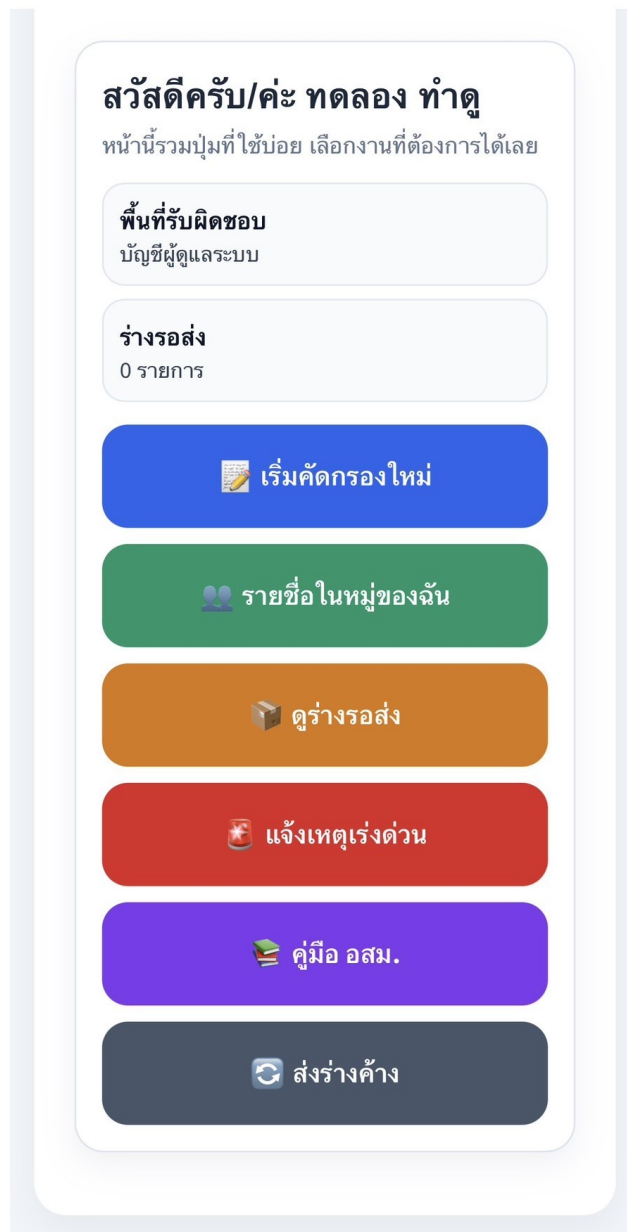
ลืมรหัสผ่าน? ตั้งรหัสใหม่ที่นี่

ภาพที่ 15: หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแลข้อมูล

บทที่ 3 การคัดกรองโดย อสม.

3.1 หน้าหลักของ อสม.

หลังเข้าสู่ระบบ จะเห็นปุ่มงานหลัก เช่น เริ่มคัดกรองใหม่ รายชื่อในหมู่บ้าน ดูร่างรอส่ง แจ้งเหตุเร่งด่วน คู่มือ และส่งร่างคำ



ภาพที่ 3: หน้าหลักของ อสม.

3.2 เริ่มคัดกรองใหม่

- 1 . กด “เริ่มคัดกรองใหม่”
- 2 . กรอกชื่อ-นามสกุล เลือกเพศ ตำบล และหมู่บ้าน
- 3 . เลือกตำบลก่อน แล้วระบบจะแสดงหมู่บ้านของตำบลนั้น
- 4 . ตีที่ยืนยันการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
- 5 . กด “ถัดไป” เพื่อเริ่มทำแบบคัดกรอง

 กลับหน้าแรก อสม.

ข้อมูลทั่วไปผู้รับการประเมิน

กรุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ที่ได้รับการประเมิน *

ตัวอย่าง : สุขภาพ จิตดี

เพศ *

-- เลือกเพศ --

ตำบล *

-- เลือกตำบล --

เลือกตำบลก่อน ระบบจะแสดงเฉพาะหมู่ที่อยู่ในตำบลนั้น เพื่อลดการส่งข้อมูลผิดพลาดและช่วยให้ LINE แจ้งเตือนไปยัง รพ.สต. ที่รับผิดชอบถูกต้อง

หมู่บ้าน *

-- เลือกตำบลก่อน --



ยืนยันการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล

*

ได้แจ้งผู้รับการประเมินแล้วว่า ข้อมูลนี้

ภาพที่ 4: กรอกข้อมูลทั่วไปผู้รับการประเมิน

ระบบคัดกรองสุขภาพจิต - โ...

×

เพศ *

-- เลือกเพศ --

ตำบล *

-- เลือกตำบล --

เลือกตำบลก่อน ระบบจะแสดงเฉพาะหมู่ที่อยู่ในตำบลนั้น เพื่อลดการส่งข้อมูลผิดพลาดและช่วยให้ LINE แจ้งเตือนไปยัง รพ.สต. ที่รับผิดชอบถูกต้อง

หมู่บ้าน *

-- เลือกตำบลก่อน --

☐ ยืนยันการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล *

ได้แจ้งผู้รับการประเมินแล้วว่า ข้อมูลนี้ใช้เพื่อคัดกรอง เฝ้าระวัง ส่งต่อ และติดตามสุขภาพจิตในพื้นที่ รพ.สต. และจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงเท่าที่จำเป็น

ถัดไป →

ภาพที่ 5: ยืนยันก่อนเริ่มคัดกรอง

3.3 แบบคัดกรอง 2Q+

2 Q+ ใช้คัดกรองอาการเศร้าเบื้องต้น ระบบจะถามอาการในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้เลือก “มี” หรือ “ไม่มี” ให้ตรงกับผู้รับการประเมิน

ถ้า 2Q+ มีความเสี่ยง

ระบบจะยังไม่ให้ส่งข้อมูลทันที และจะแจ้งให้ทำ 9 Q ต่อ เพื่อดูระดับความรุนแรงให้ละเอียดขึ้น

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q+



💡 ใช้คัดกรองความเสี่ยงซึมเศร้าเบื้องต้นด้วย 2Q+

📅 ส่วนที่ 1: ข้อคำถามคัดกรองซึมเศร้า
2Q+ (บังคับกรอก)

1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งวันนี้ ท่านมี
อาการหดหู เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่?

☐ ไม่มี☐ มี

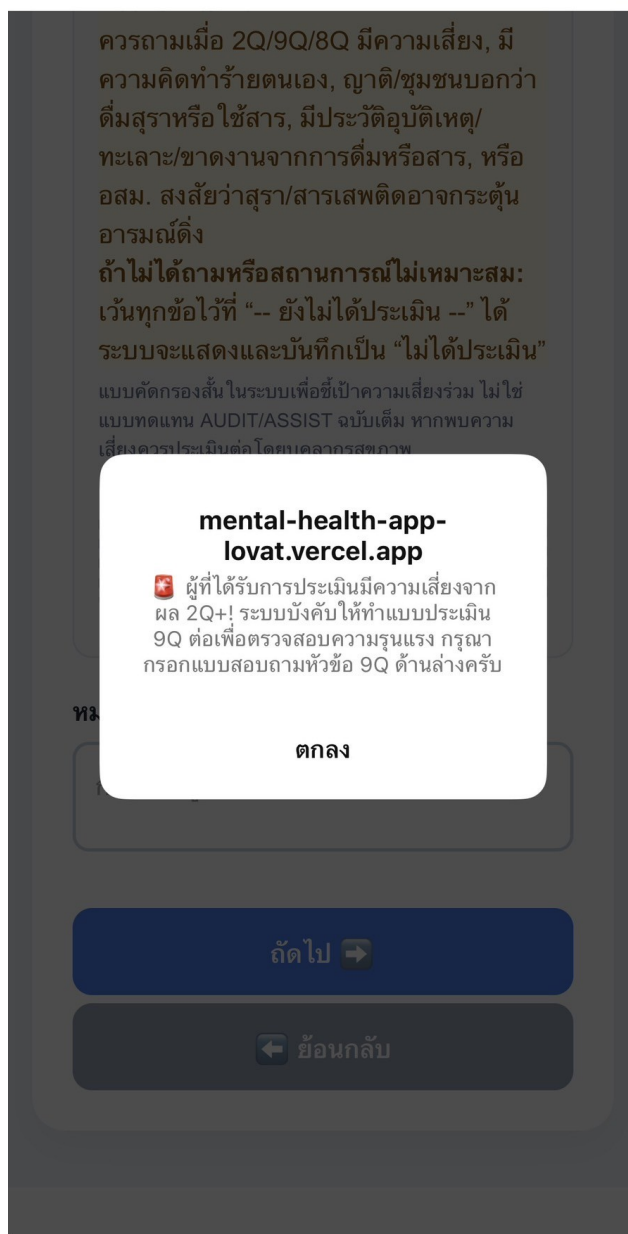
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งวันนี้ ท่านมี
อาการเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่?

☐ ไม่มี☐ มี

3. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งวันนี้ ท่าน
รู้สึกเครียด กังวลใจ หรือไม่สบายใจจน
กระทบการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่?

☐ ไม่มี☐ มี

ภาพที่ 6: แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q+



ภาพที่ 10: ระบบแจ้งให้ทำ 9Q เมื่อผล 2Q+ มีความเสี่ยง

3.4 แบบประเมินเสริม

นอกจาก 2 Q+ ระบบมีแบบประเมินเสริม เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพรวมของผู้รับบริการมากขึ้น

แบบประเมิน	ใช้เมื่อใด	สิ่งที่ควรรู้
9 Q	เมื่อ 2 Q+ มีความเสี่ยง	ใช้ดูระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า
8 Q	เมื่อมีความเสี่ยงที่ต้องประเมินความปลอดภัย	ใช้ประกอบการติดตามและส่งต่อ
ST-5	เมื่อมีความเครียดหรือมีปัจจัยกดดัน	ถ้าสถานการณ์ไม่เหมาะสม สามารถบันทึกเป็น "ไม่ได้ประเมิน" ได้
ปัจจัยร่วมทางคลินิก	เมื่อมีข้อมูลโรคประจำตัวหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	เป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่การวินิจฉัยแทนแพทย์

Alcohol/Substance 10X	เมื่อสงสัยเกี่ยวกับสุรา สารเสพติด หรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เป็นแบบคัดกรองสั้น ไม่แทนแบบ ประเมินฉบับเต็ม
-----------------------	--	---

ระบบคัดกรองสุขภาพจิต - โ...

×

🔪

ส่วนที่ 4: แบบประเมินความเครียด ST-5

ควรประเมิน ST-5 เมื่อใด?

ควรถามเมื่อผู้รับการประเมินมีความเครียดจากปัญหาครอบครัว/งาน/เงิน/การเจ็บป่วย, นอนไม่หลับ, หงุดหงิดง่าย, เบื่อ เซ็ง, ไม่อยากพบคน, หรือเมื่อ 2Q/9Q/8Q มีความเสี่ยงและต้องการข้อมูลความเครียดประกอบการดูแล

ถ้าไม่ได้ถามหรือสถานการณ์ไม่เหมาะสม: ไม่ต้องกดประเมิน ระบบจะแสดงและบันทึกเป็น “ไม่ได้ประเมิน”

ST-5 เป็นแบบคัดกรองระดับความเครียดเบื้องต้น ใช้เพื่อช่วยคัดกรองและวางแผนติดตาม ไม่ใช่การวินิจฉัยแทนบุคลากรสุขภาพ

+ ต้องการประเมิน ST-5

🩺

ส่วนที่ 5: ประวัติโรคประจำตัวเดิม / ปัจจุบันร่วมทางคลินิก

ควรกรอกเมื่อใด?

ควรถาม/ติ๊กเมื่อผู้รับการประเมินมีคะแนน 2Q/9Q/8Q เสี่ยง, มีประวัติเคยรักษาจิตเวช, ใช้ยาจิตเวชหรือชาดยา, มีโรคทางกายเรื้อรัง/ปวดเรื้อรัง/มะเร็ง/ไทรอยด์, มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง หรือ อสม. สังเกตว่าปัจจัยเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้ป่วย

ภาพที่ 7: คำแนะนำแบบประเมิน ST-5

คู่มือระบบคัดกรองสุขภาพจิต - ฉบับปรับปรุง | หน้า 1 3

📋 ส่วนที่ 5: ประวัติโรคประจำตัวเดิม / ปัจจัยร่วมทางคลินิก

ควรกรอกเมื่อใด?

ควรถาม/ตักเมื่อผู้รับการประเมินมีคะแนน
2Q/9Q/8Q เสี่ยง, มีประวัติเคยรักษาจิตเวช,
ใช้ยาจิตเวชหรือชาดยา, มีโรคทางกาย
เรื้อรัง/ปวดเรื้อรัง/มะเร็ง/ไทรอยด์, มีอาการ
นอนไม่หลับเรื้อรัง หรือ อสม. สังเกตว่า
ปัจจัยเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้
ป่วย

ถ้าไม่ได้ถามหรือไม่ทราบ: เว้นว่างไว้ได้
ระบบจะแสดงและบันทึกเป็น “ไม่ได้ประเมิน”
เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าไม่มีโรคจริง

ใช้เป็นข้อมูลประกอบให้ทีมโรงพยาบาลประเมินเคสได้
แม่นยำขึ้น ไม่ใช้การวินิจฉัยแทนแพทย์

+ ต้องการประเมิน/บันทึกปัจจัยร่วมทาง
คลินิก

🍷 ส่วนที่ 6: Alcohol / Substance Screening - 10X

ควรกรอกเมื่อใด?

ควรถามเมื่อ 2Q/9Q/8Q มีความเสี่ยง, มี
ความคิดทำร้ายตนเอง, ญาติ/ชุมชนบอกว่า
สิ่งผิดปกติเกี่ยวกับผู้ถูกประเมิน

ภาพที่ 8: ปัจจัยร่วมทางคลินิกและ 10X

🍷

ส่วนที่ 6: Alcohol / Substance Screening - 10X

ควรกรอกเมื่อใด?

ควรถามเมื่อ 2Q/9Q/8Q มีความเสี่ยง, มีความคิดทำร้ายตนเอง, ญาติ/ชุมชนบอกว่าดื่มสุราหรือใช้สาร, มีประวัติอุบัติเหตุ/ทะเลาะ/ขาดงานจากการดื่มหรือสาร, หรืออสม. สงสัยว่าสุรา/สารเสพติดอาจกระตุ้นอาการนี้

ถ้าไม่ได้ถามหรือสถานการณ์ไม่เหมาะสม: เว้นทุกข้อไว้ที่ "-- ยังไม่ได้ประเมิน --" ได้ ระบบจะแสดงและบันทึกเป็น "ไม่ได้ประเมิน"

แบบคัดกรองสั้น ในระบบเพื่อชี้เป้าความเสี่ยงร่วม ไม่ใช่แบบทดแทน AUDIT/ASSIST ฉบับเต็ม หากพบความเสี่ยงควรประเมินต่อโดยบุคลากรสุขภาพ

+

ต้องการประเมิน Alcohol / Substance 10X

หมายเหตุ (ถ้ามี)

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม...

ถัดไป ➡

⬅ ย้อนกลับ

ภาพที่ 9: คำแนะนำ Alcohol / Substance Screening - 10X

บทที่ 4 การตรวจสอบและส่งข้อมูล

ก่อนส่งข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบความถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลอีกครั้ง เช่น ชื่อ เพศ ตำบล หมู่บ้าน ผล 2 Q+ ผล 9 Q ผล 8 Q ผล -B และหมายเหตุ

- 1 . ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปว่าถูกต้องหรือไม่
- 2 . ตรวจสอบผลแบบคัดกรองว่าเลือกคำตอบครบหรือไม่
- 3 . ถ้าพร้อมส่ง ให้กด "ส่งข้อมูลบันทึกผลแล้ว"
- 4 . ถ้ายังไม่พร้อมหรืออินเทอร์เน็ตไม่ดี ให้กด "บันทึกร่างไว้ในเครื่อง"

 ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล:

เพศ:

ตำบล:

หมู่บ้าน:

 ผลการคัดกรองแยกหัวข้อเครื่องมือส่งข้อมูล แบบประเมินผลสมระดับ
หลัก: 2Q+ผลประเมินด้าน 2Q+:  ปกติจาก 2Q+ราย ข้อ1 เคร้า/ท่อแท้=ไม่มี | ข้อ2
ละเอียด เบื่อ/ไม่เฟลิตเฟลีน=ไม่มี | ข้อ3
คำตอบ เครียด/กังวลกระทบชีวิต=ไม่มี
2Q+:

คะแนนสรุป 9Q: -(ไม่ได้ประเมิน)-

คะแนนสรุป 8Q: -(ไม่ได้ประเมิน)-

ภาพที่ 11: ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล

2Q+:

คะแนนสรุป 9Q: -(ไม่ได้ประเมิน)-

คะแนนสรุป 8Q: -(ไม่ได้ประเมิน)-

ผลประเมิน ST-5: ไม่ได้ประเมิน

หมายเหตุผู้คัดกรอง: -(ว่าง)-

👤 ปัจจัยร่วม / สารเสพติด

Psychiatric co-morbidities: ไม่ได้ประเมิน

โรคทางกาย/ปัจจัยร่วม: ไม่ได้ประเมิน

Alcohol/Substance 10X: ไม่ได้ประเมิน

📄 ส่งข้อมูลบันทึกคลาวด์

💾 บันทึกร่างไว้ในเครื่อง

⬅️ ย้อนกลับแก้ไข

ภาพที่ 12: ปุ่มส่งข้อมูลและปุ่มบันทึกร่าง

ข้อควรระวัง

ถ้าบันทึกร่างไว้ในเครื่อง ข้อมูลยังไม่เข้าระบบกลาง

เมื่อมีอินเทอร์เน็ต ให้กลับมาส่งร่างค้างอีกครั้ง

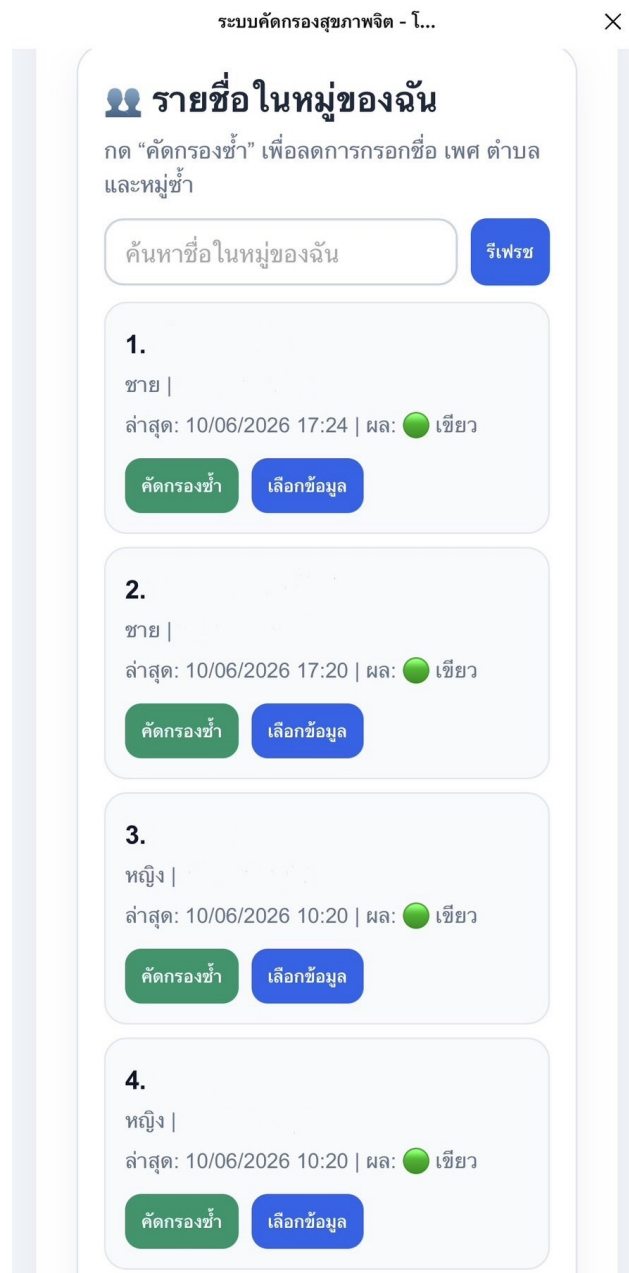
บทที่ 5 การติดตามในหมู่บ้านและร่างออฟไลน์

5.1 รายชื่อในหมู่บ้าน

หน้านี้ใช้ค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้านเดิม เพื่อคัดกรองซ้ำหรือนำข้อมูลเดิมมาใช้ ลดการกรอกข้อมูลซ้ำ

- กด “คัดกรองซ้ำ” เมื่อต้องประเมินคนเดิมอีกครั้ง

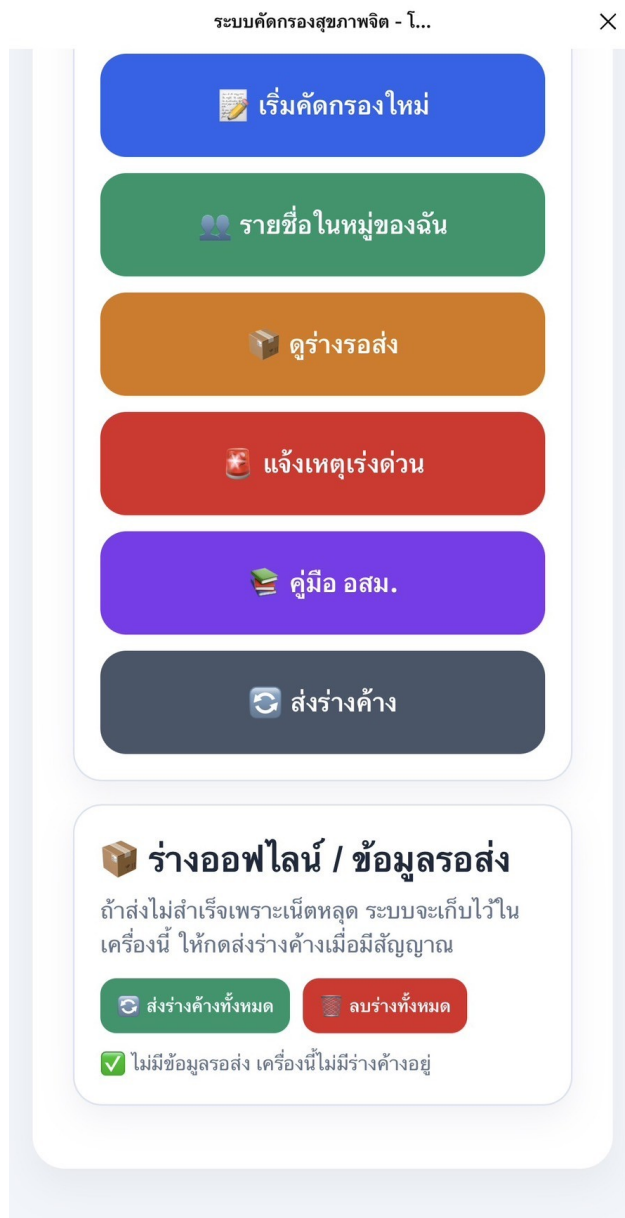
- กด “เลือกข้อมูล” เมื่อต้องการดึงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยมาใช้
- กด “รีเฟรช” เมื่อต้องการโหลดรายชื่อใหม่



ภาพที่ 13: รายชื่อในหมู่ของฉัน

5.2 ร้างออฟไลน์ / ข้อมูลรอส่ง

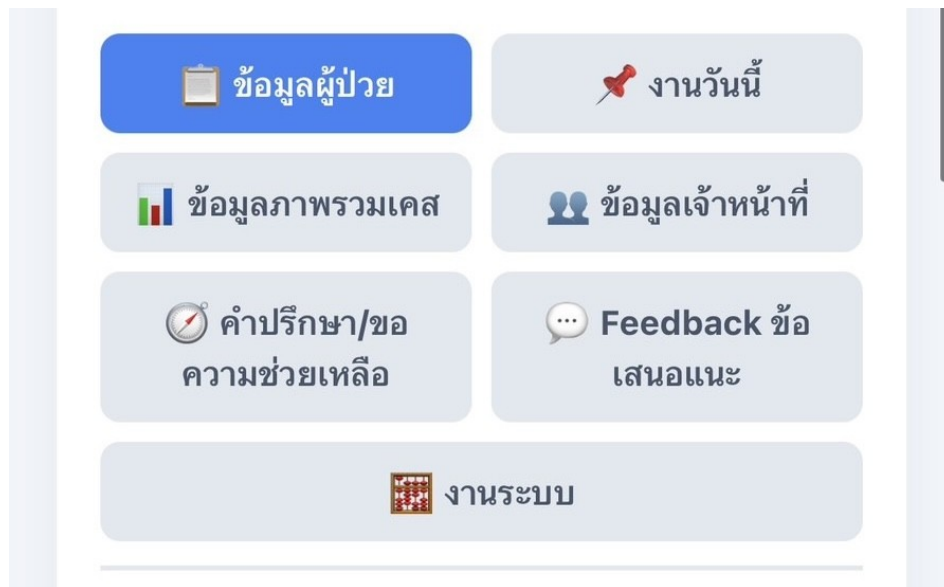
ถ้าส่งข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบจะเก็บร่างไว้ในเครื่อง ผู้ใช้สามารถกลับมาส่งใหม่ได้ภายหลัง



ภาพที่ 14: ร่างออฟไลน์และข้อมูลรอส่ง

บทที่ 6 แดชบอร์ดผู้ดูแลข้อมูล

แดชบอร์ดผู้ดูแลใช้ดูภาพรวม ติดตามเคส ตรวจสอบข้อมูล และจัดการระบบตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน



ภาพที่ 16: เมนูหลักของแดชบอร์ดผู้ดูแล

6.1 เมนูหลักที่พบบ่อย

เมนู	ใช้ทำอะไร
ข้อมูลผู้ป่วย	ค้นหา ดูรายละเอียด แก้ไข และติดตามผู้ป่วย
งานวันนี้	ดูเคสที่ต้องรีบติดตาม เช่น เคสแดง SLA เกินกำหนด หรือรอจองคิว
ข้อมูลภาพรวมเคส	ดูจำนวนผู้ป่วยตามระดับความเสี่ยงและสรุปรายพื้นที่
ข้อมูลเจ้าหน้าที่	เพิ่ม แก้ไข ค้นหา หรือส่งออกรายชื่อเจ้าหน้าที่
คำปรึกษา/ขอความช่วยเหลือ	ดูคำขอจากชาวบ้านหรือช่องทางสาธารณะ
Feedback ข้อเสนอแนะ	ดูข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน โดยไม่เปิดเผยตัวตน
งานระบบ	ตรวจสอบสุขภาพระบบ สำรองข้อมูล และเครื่องมือขั้นสูง

บทที่ 7 การดูข้อมูลผู้ป่วยและติดตามเคส

7.1 ค้นหาและตรวจรายชื่อซ้ำ

ก่อนเพิ่มหรือรวมข้อมูลผู้ป่วย ควรตรวจสอบซ้ำก่อน เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลซ้ำในระบบ

 **ตรวจรายชื่อซ้ำ**

ค้นหาชื่อ/เพศ/หมู่บ้านที่คล้ายกัน เพื่อช่วยลดข้อมูลซ้ำก่อนใช้ระบบรวมผู้ป่วย

 ตรวจรายชื่อซ้ำ

 Patient ID:

| หมู่บ้าน:

| เพศ: ชาย

อายุ

คำนวณ: ยังไม่ระบุวันเกิด

 สถานะการรับเคสล่าสุด:

 ยังไม่จองคิว

รวม 1 เคส | จองคิวแล้ว 0 | ยังไม่จองคิว 1

 ยังไม่มีเวลาจองคิว

ความเสี่ยงสูงสุด:  เขียว

— แนวโน้ม 9Q: ยังไม่มีข้อมูล 9Q ก่อนหน้า

คลิกดูข้อมูลเชิงลึก 

ล่าสุด: 10/06/2026 17:24

 Patient ID:

| หมู่บ้าน:

| เพศ: ชาย

อายุ

คำนวณ: ยังไม่ระบุวันเกิด

 สถานะการรับเคสล่าสุด:

 ยังไม่จองคิว

รวม 1 เคส | จองคิวแล้ว 0 | ยังไม่จองคิว 1

 ยังไม่มีเวลาจองคิว

ความเสี่ยงสูงสุด:  เขียว

— แนวโน้ม 9Q: ยังไม่มีข้อมูล 9Q ก่อนหน้า

ภาพที่ 17: ตรวจรายชื่อซ้ำก่อนรวมผู้ป่วย

7.2 หน้ารายละเอียดผู้ป่วย

หน้ารายละเอียดผู้ป่วยจะแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น Patient ID เพศ อายุ หมู่บ้าน ระดับความเสี่ยง สถานะจองคิว SLA และแนวโน้ม 9 Q

Patient ID:
 เพศ: ชาย อายุ: ไม่ระบุวันเกิด
 หมู่ที่: ยังไม่จ้องคิว
 Risk ล่าสุด: ● เขียว
 SLA: อยู่ในกำหนด / กำหนด 10/07/2026
 — แนวโน้ม 9Q: ยังไม่มีข้อมูล 9Q ก่อนหน้า

ข้อมูลการประเมิน ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลเปรียบเทียบ Timeline/Note

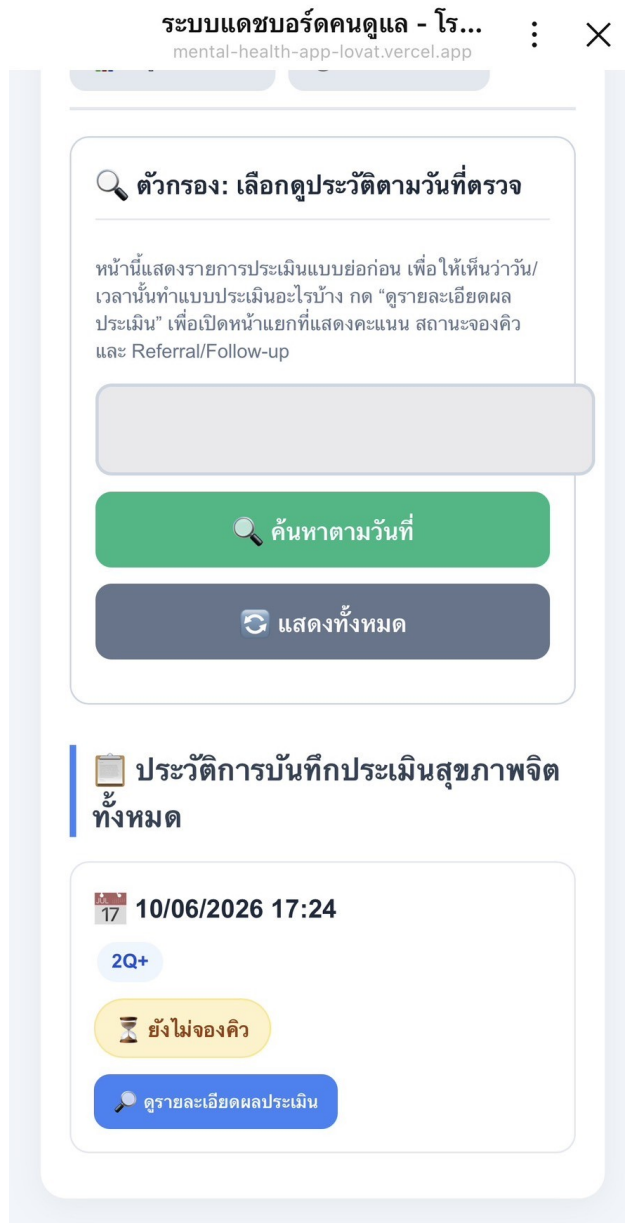
ตัวกรอง: เลือกดูประวัติตามวันที่ตรวจ

หน้านี้แสดงรายการประเมินแบบย้อนก่อน เพื่อให้เห็นว่าวัน/เวลานั้นทำแบบประเมินอะไรบ้าง กด "ดูรายละเอียดผลประเมิน" เพื่อเปิดหน้าต่างที่แสดงคะแนน สถานะจ้องคิว และ Referral/Follow-up

ภาพที่ 18: หน้ารายละเอียดผู้ป่วยและเก็บข้อมูล

7.3 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย

ใช้ดูข้อมูลพื้นฐาน เช่น Patient ID ชื่อ เพศ อายุ หมู่ที่ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น ถ้าต้องแก้ไข ให้กด “แก้ไขข้อมูลทั่วไป”



ภาพที่ 19: ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย

7.4 ประวัติการประเมิน

ใช้ดูประวัติการคัดกรองย้อนหลัง สามารถกรองตามวันที่ เพื่อดูผลประเมินแต่ละครั้งและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย

 แก้ไขข้อมูลทั่วไป



Patient ID

ถาวร

ชื่อ-นามสกุล

เพศ

ชาย

อายุคำนวณ

ไม่ระบุวันเกิด

หมู่ที่

วันเดือนปีเกิด

ไม่ระบุ

ประวัติแพ้ยา/อาหาร

ยังไม่ระบุ

ภาพที่ 20: ตัวกรองประวัติการประเมิน

7.5 เปรียบเทียบผลย้อนหลัง

แท็บนี้ช่วยเปรียบเทียบผลครั้งก่อนหน้าและครั้งล่าสุด เช่น 2 Q+ หรือระดับความเสี่ยง เพื่อดูแนวโน้มของผู้ป่วย

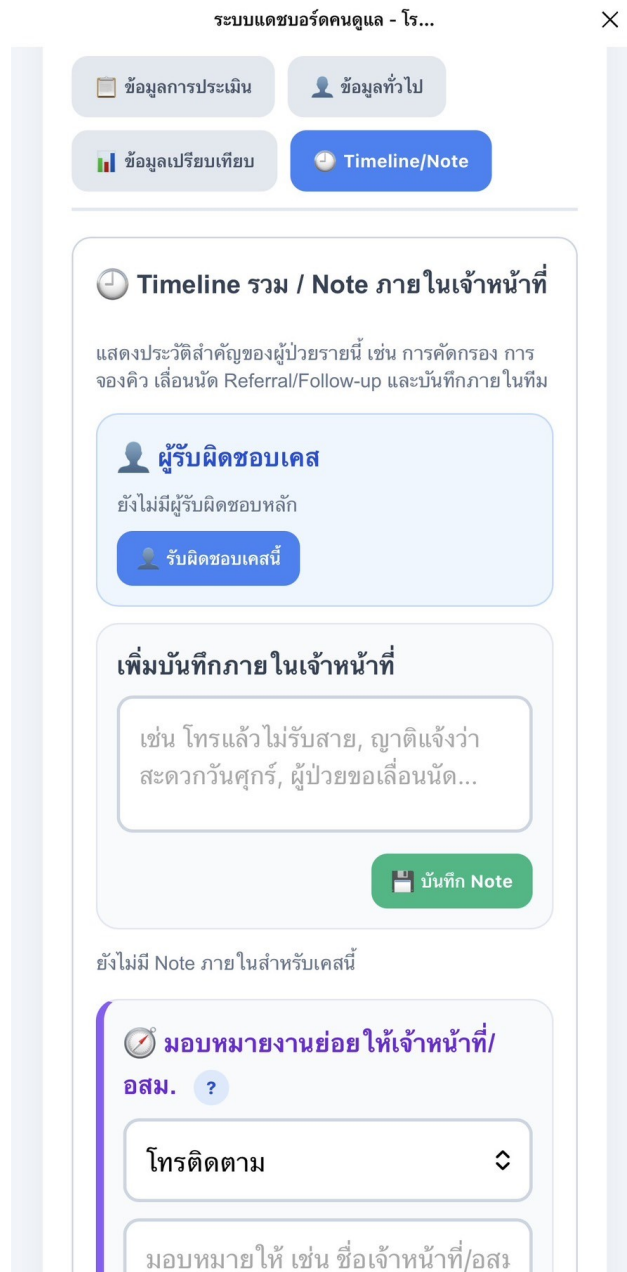


ภาพที่ 21: เปรียบเทียบผลประเมินย้อนหลัง

7.6 Timeline / Note ภายในเจ้าหน้าที่

ใช้บันทึกเรื่องสำคัญของเคส เช่น การโทรติดตาม การเลื่อนนัด การจองคิว การส่งต่อ หรือบันทึกภายในทีม

- กด “รับผิดชอบเคสนี้” เมื่อต้องการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
- พิมพ์บันทึกภายใน แล้วกด “บันทึก Note”
- มอบหมายงานย่อยให้เจ้าหน้าที่หรือ อสม. ได้
- บันทึกแผนติดตาม และปิดเคสเมื่อไม่ต้องติดตามต่อ



ภาพที่ 22: Timeline และ Note ภายในเจ้าหน้าที่

ระบบแดชบอร์ดคนดูแล - โร...

×

🕒

มอบหมายงานย่อยให้เจ้าหน้าที่/อสม. ?

โทรติดตาม

◇

มอบหมายให้ เช่น ชื่อเจ้าหน้าที่/อสม

ยังไม่เริ่ม

◇

รายละเอียดงานย่อย เช่น โทรถามอาการภายใน 3 วัน / ให้ อสม.ช่วย

📄

บันทึกงานย่อย

ยังไม่มีงานย่อยที่มอบหมายในเคสนี้

📄

ประวัติการแก้ไขข้อมูลสำคัญ ?

โหลดประวัติการแก้ไข

📄

17 แผนติดตามผู้ป่วย

ตั้งวันติดตามครั้งถัดไป ผู้ติดตาม และช่องทางติดตาม ระบบจะบันทึกแผนและอัปเดตสถานะติดตามในแถวประเมินล่าสุดเท่าที่ทำได้

ภาพที่ 23: มอบหมายงานย่อยและประวัติการแก้ไข

17 แผนติดตามผู้ป่วย

ตั้งวันติดตามครั้งถัดไป ผู้ติดตาม และช่องทางติดตาม ระบบจะบันทึกแผนและอัปเดตสถานะติดตามในแถวประเมินล่าสุดเท่าที่ทำได้

ผู้ติดตามหลัก เช่น เจ้าหน้าที่/อสม./

โทรศัพท์



รอติดตาม



หมายเหตุแผนติดตาม เช่น โทรถาม
อาการหลังพบแพทย์ / ให้ อสม.เยี่ยม



บันทึกแผนติดตาม

✓ ปิดเคสแบบมีเหตุผล

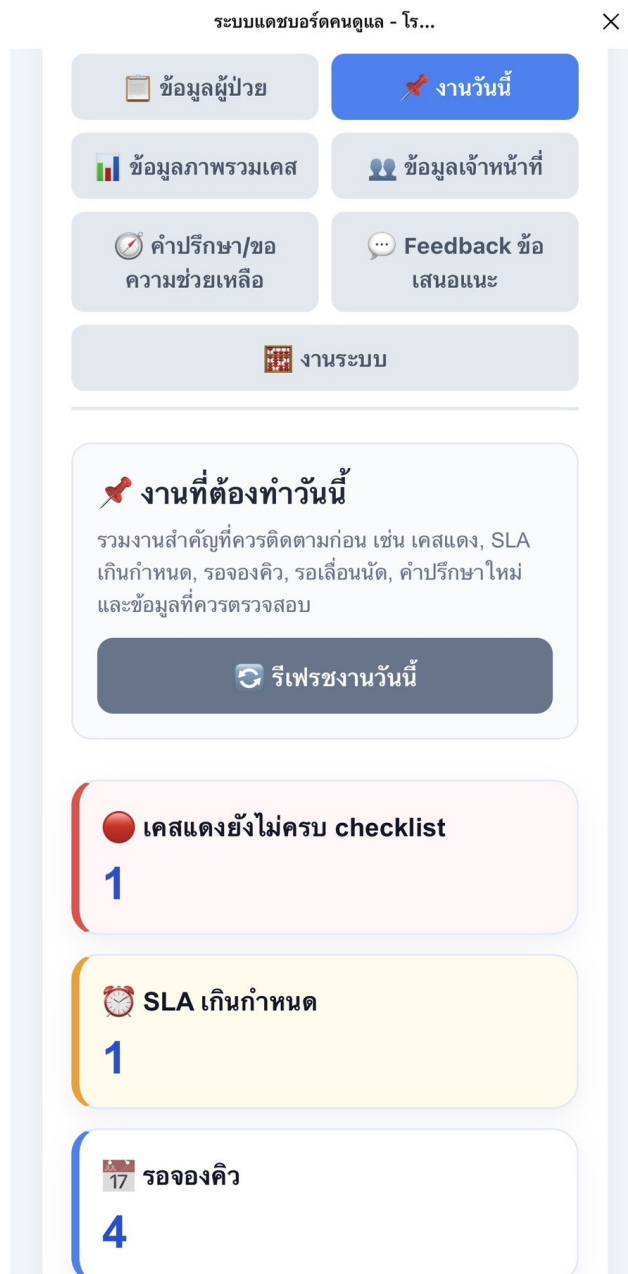
ใช้เมื่อเคสไม่ต้องติดตามในระบบต่อไปแล้ว ต้องเลือกเหตุผลและกรอกหมายเหตุสั้น ๆ เพื่อเก็บประวัติ

-- เลือกเหตุผลการปิดเคส --



หมายเหตุการปิดเคส เช่น ส่งต่อ
สำเร็จและมีญาติดูแล / อาการดีขึ้น

ภาพที่ 24: แผนติดตามและปิดเคส



ภาพที่ 26: งานที่ต้องทำวันนี้

8.2 ศูนย์แจ้งเตือน Admin

ศูนย์แจ้งเตือนช่วยรวมเคสที่ต้องตรวจซ้ำหรือเคสที่ถึงกำหนดติดตาม กด “เปิดเคส” เพื่อไปหน้ารายละเอียดผู้ป่วย

ระบบแดชบอร์ดคนดูแล - โร...

✕

 ศูนย์แจ้งเตือน Admin ?

เคสแดงยังไม่ครบ checklist

· ต้องรีบตรวจสอบความผิดปกติ

เปิดเคส

SLA เกินกำหนด

· เกินกำหนด · กำหนด 10/06/2026

เปิดเคส

 17 ปฏิทินนัดหมายและติดตาม ?

ดูภายใน

14 วัน

รีเฟรชปฏิทิน

16/6/2569

กำหนด SLA

เปิดเคส

16/6/2569

กำหนด SLA

ภาพที่ 27: ศูนย์แจ้งเตือนและปฏิทินติดตาม

8.3 งานค้าง/งานด่วน และกะเบียดติดตาม

ใช้ดูรายการที่ยังต้องจัดการ เช่น รอองคิว เคสแดง SLA เกินกำหนด หรือเคสที่ควรติดตามต่อ

รายการงานค้าง/งานด่วน

รออนุมัติ

· Risk 🟡 เหลือง

เปิดเคส

เคสแดงยังไม่ครบ checklist

เปิดเคส

SLA เกินกำหนด

· เกินกำหนด · กำหนด 10/06/2026

เปิดเคส

รออนุมัติ

· Risk 🔴 แดง

เปิดเคส

รออนุมัติ

· Risk 🟡 เหลือง

เปิดเคส

รออนุมัติ

· Risk 🟡 เหลือง

เปิดเคส

ภาพที่ 28: รายการงานค้าง/งานด่วน


ทะเบียนเคสที่ต้องติดตาม

รวมเคสที่ยังไม่ปิด มีวันติดตาม หรือมีสถานะที่ควรติดตาม
ต่อ ให้อัปเดตประชุมทีม/ตามงานประจำวัน


 เหลือง ·

ติดตาม: - · สถานะ:


 ยังไม่ระบุ


 เปิดเคส


 แดง ·

ติดตาม: - · สถานะ:


 ยังไม่ระบุ


 เปิดเคส


 เหลือง ·

ติดตาม: - · สถานะ:


 ยังไม่ระบุ


 เปิดเคส


 เหลือง ·

ติดตาม: - · สถานะ:


 ยังไม่ระบุ


 เปิดเคส


 เขียว ·

ติดตาม: - · สถานะ:


 ยังไม่ระบุ


 เปิดเคส

ภาพที่ 29: ทะเบียนเคสที่ต้องติดตาม

8.4 สรุปภาพรวมเคส

หน้านี้ช่วยดูภาพรวมผู้ป่วยตามระดับความเสี่ยง แยกเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง



สรุปลี้ความเสี่ยงปัจจุบันของผู้ป่วย

ผู้ป่วยทั้งหมดปัจจุบัน

16

นับผู้ป่วยไม่ซ้ำจากผลล่าสุดของแต่ละคน

สีเขียวปัจจุบัน

12

ผู้ป่วยที่ผลล่าสุดยังไม่พบความเสี่ยงเด่น

สีเหลืองปัจจุบัน

3

ผู้ป่วยที่ผลล่าสุดควรติดตาม/ซักเพิ่ม

สีแดงปัจจุบัน

1

ผู้ป่วยที่ผลล่าสุดควรจัดการเร่งด่วน

ภาพที่ 30: สรุปลี้ความเสี่ยงปัจจุบัน



สรุปความเสี่ยงปัจจุบันรายหมู่บ้าน

นับจากผลประเมินล่าสุดของผู้ป่วยแต่ละคน ไม่ใช่จำนวนรายการประเมินทั้งหมด

แดงปัจจุบัน 1

เหลืองปัจจุบัน 3

เขียวปัจจุบัน 12

รวม 16



สรุปคุณภาพงานรายพื้นที่ ?

แยกตามตำบล



คำนวณใหม่

รวม 16 | เขียว 12 | เหลือง 3 | แดง 1 | เกิน SLA 1 |
รอกอง 4 | ติดตามวันนี้ 0 | ปิดเคส 0



Check-in งานประจำวันของเจ้าหน้าที่ ?

?

14 มิ.ย. 2569

แสดงข้อมูลวันนั้น

ยังไม่มีรายการคัดกรองวันที่ 14/06/2026

ภาพที่ 31: สรุปรายหมู่บ้านและคุณภาพงานรายพื้นที่

สรุปเคสรวมทั้งหมดจากทุกรายการคัดกรอง

รายการคัดกรองรวมทั้งหมด

17

นับทุกครั้งที่มีการคัดกรอง ไม่ตัดซ้ำผู้ป่วย

● เคสเขียวรวมทั้งหมด

13

จำนวนรายการประเมินที่อยู่ระดับเขียว

● เคสเหลืองรวมทั้งหมด

3

จำนวนรายการประเมินที่อยู่ระดับเหลือง

● เคสแดงรวมทั้งหมด

1

จำนวนรายการประเมินที่อยู่ระดับแดง

สรุปเคสรวมทั้งหมดรายหมู่บ้าน

นับจากรายการคัดกรองทุกครั้งในระบบ เหมาะสำหรับดู
ปริมาณงานสะสมและจำนวนแบบประเมินทั้งหมด

แดงรวม 1

เหลืองรวม 3

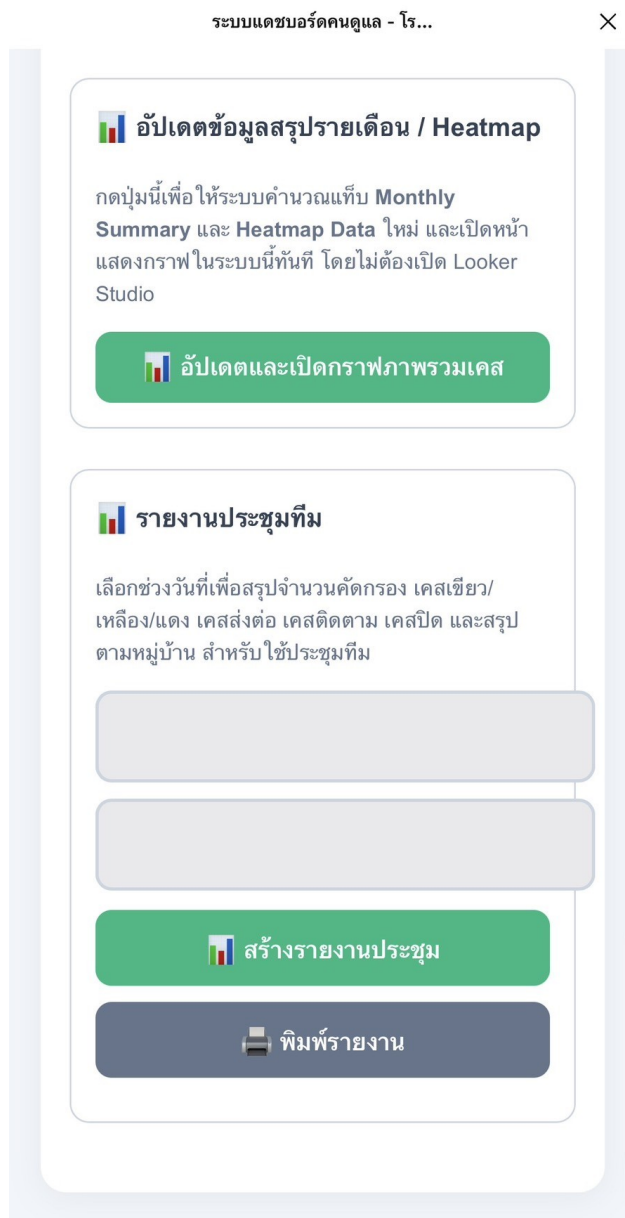
เขียวรวม 13

รวม 17

ภาพที่ 32: สรุปเคสรวมทั้งหมด

8.5 รายงานรายเดือนและรายงานประชุมทีม

ผู้ดูแลสามารถกดอัปเดตข้อมูลรายเดือนและ Heatmap เพื่อดูกราฟในระบบ แล้วสร้างรายงานประชุมหรือพิมพ์รายงานได้



ภาพที่ 33: อัปเดตสรุปรายเดือนและรายงานประชุมทีม

บทที่ 9 จัดการเจ้าหน้าที่

เมนูข้อมูลเจ้าหน้าที่ใช้เพิ่ม ค้นหา กรอง และแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานในระบบ

ใครควรใช้เมนูนี้

เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบหรือโรงพยาบาลเท่านั้น

ไม่ควรให้ผู้ใช้งานทั่วไปเห็นรหัสผ่านหรือรหัสลับบัญชี

ระบบแดชบอร์ดคนดูแล - โร...

ข้อมูลผู้ป่วย

งานวันนี้

ข้อมูลภาพรวมเคส

ข้อมูลเจ้าหน้าที่

คำปรึกษา/ขอความช่วยเหลือ

Feedback ข้อเสนอแนะ

งานระบบ

+ เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าระบบ

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการเพิ่มบัญชี Hospital / Admin / VHV ใหม่

ค้นหา/กรองเจ้าหน้าที่

พิมพ์ค้นหาชื่อ / นามสกุล / Username /

ทุกยศ

รีเฟรช

โหลดรายชื่อจาก backend แบบแบ่งหน้า เพื่อรองรับเจ้าหน้าที่จำนวนมาก โดยแสดงครั้งละ 50 คน

แสดง 1-50 จาก 314 คน | หน้า 1 / 7

ภาพที่ 34: เพิ่มและค้นหาเจ้าหน้าที่

ระบบแดชบอร์ดคนดูแล - โร...

×

แสดง 1-50 จาก 314 คน | หน้า 1 / 7

← ก่อนหน้า

แสดง 1-50 จาก 314 คน | หน้า 1 / 7

ถัดไป →

ชื่อ-นามสกุล: Hospital

Username:

ตำแหน่ง:

-

รหัสเข้าใช้งาน (Password):

..... (กดตาเพื่อแสดง)

รหัสลับกู้บัญชี:

..... (กดตาเพื่อแสดง)

LINE User ID:

ผูกแล้ว

LINE Updated At:

14/06/2026 17:34

แก้ไข

ลบออก

ชื่อ-นามสกุล: Hospital

Username:

ตำแหน่ง:

ภาพที่ 35: ข้อมูลเจ้าหน้าที่และการแก้ไข/ลบ

สิ่งที่ทำได้	คำอธิบายง่าย ๆ
เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าระบบ	ใช้เมื่อมีผู้ใช้ใหม่ เช่น Hospital, Admin หรือ VHV
ค้นหา/กรองเจ้าหน้าที่	ค้นหาจากชื่อ นามสกุล หรือ Username
แก้ไขข้อมูล	ปรับชื่อ ตำแหน่ง รหัสผ่าน หรือข้อมูลที่จำเป็น
ลบออก	ใช้เมื่อไม่ต้องการให้บัญชีนั้นใช้งานต่อ
แบ่งหน้า	ระบบแสดงครั้งละ 50 คน เพื่อให้เปิดได้เร็วขึ้น

บทที่ 1 0 คำปรึกษา Feedback และงานระบบ

10.1 คำปรึกษา/ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

หน้านี้รวมคำขอช่วยเหลือจากช่องทางสาธารณะ เช่น consult.html, selfcheck.html หรือ urgent.html เจ้าหน้าที่สามารถรับเรื่อง บันทึกการติดต่อ นัดหมาย ส่งต่อ หรือปิดเรื่องได้



ภาพที่ 36: คำปรึกษาและคำขอความช่วยเหลือ

ระบบแดชบอร์ดคนดูแล - โร...

×

ค้นหา/กรองคำขอปรึกษา

ค้นหาชื่อ เรื่อง พื้นที่ หรือรายละเอียด...

ทุกสถานะ

ทุกระดับความเร่งด่วน

รีเฟรช

คำขอทั้งหมด

0

จำนวนคำขอปรึกษาที่แสดงในระบบ

NEW คำขอใหม่

0

ยังไม่มีผู้รับเรื่อง

เร่งด่วน

0

ควรประเมินความปลอดภัยโดยเร็ว

ยังเปิดเรื่อง

0

ยังไม่มีปิดเรื่อง

ภาพที่ 37: ตัวกรองและสรุปจำนวนคำขอ

10.2 Feedback ข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้งานส่งข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหาได้แบบไม่เปิดเผยตัวตน ระบบจะไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้หรือสิทธิ์การเข้าถึงไว้กับข้อความ

🖥️ ผู้ใช้งานปัจจุบัน: ทดลอง ทำดู
Hospital

🔒 ออกจาก
ระบบ

📅 ข้อมูลผู้ป่วย

📌 งานวันนี้

📊 ข้อมูลภาพรวมเคส

👤 ข้อมูลเจ้าหน้าที่

🕒 ค่าปรึกษา/ขอ
ความช่วยเหลือ

💬 Feedback ข้อ
เสนอแนะ

🏠 งานระบบ

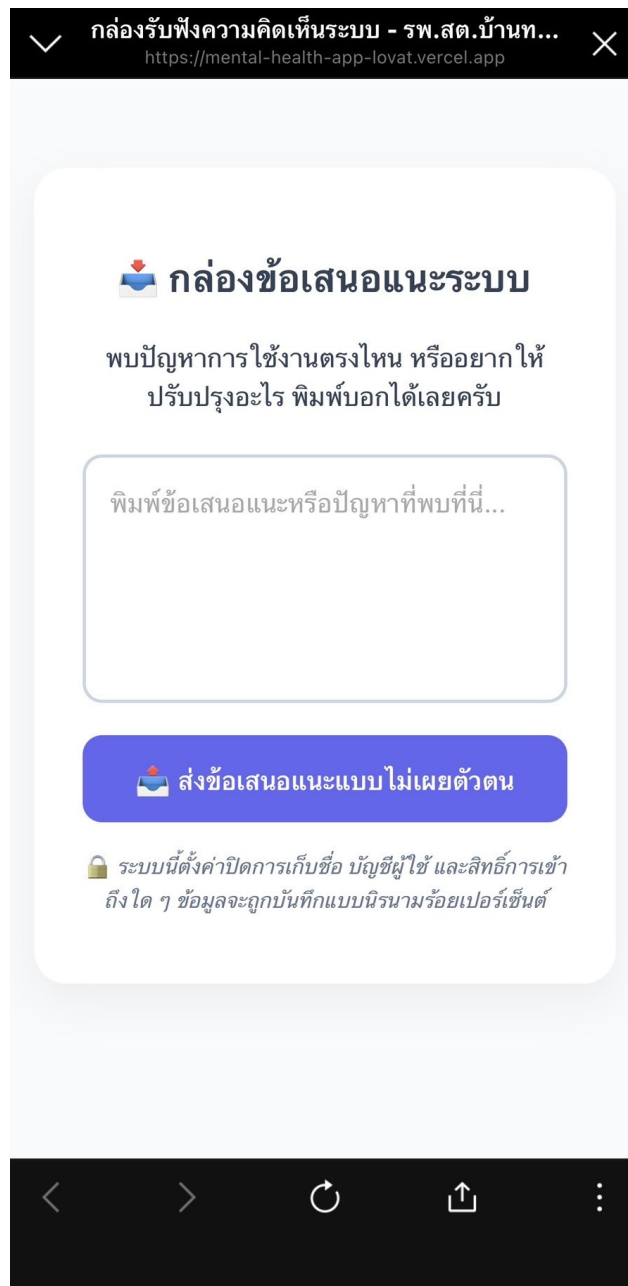
💬 กล่องข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน
ระบบ (Anonymous)

รวมเสียงสะท้อนเพื่อนำไปปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบลือกัดกรอง ข้อมูลส่งมาแบบนิรนามและ
ไม่มีการบันทึกชื่อตัวตน

👤 แหล่งข้อมูล: ผู้ใช้งานระบบ (ไม่เผยแพร่ตัวตน)

🕒 เวลาบันทึก: 09/06/2026 09:51 น.

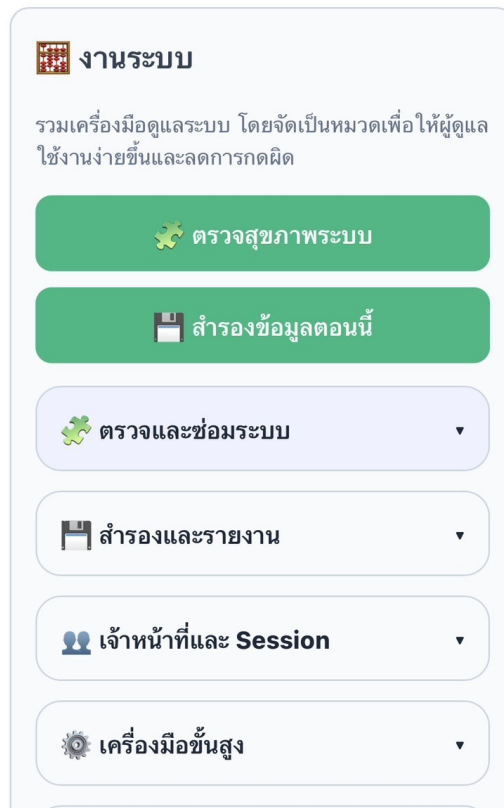
ภาพที่ 38: Feedback จากผู้ใช้งาน



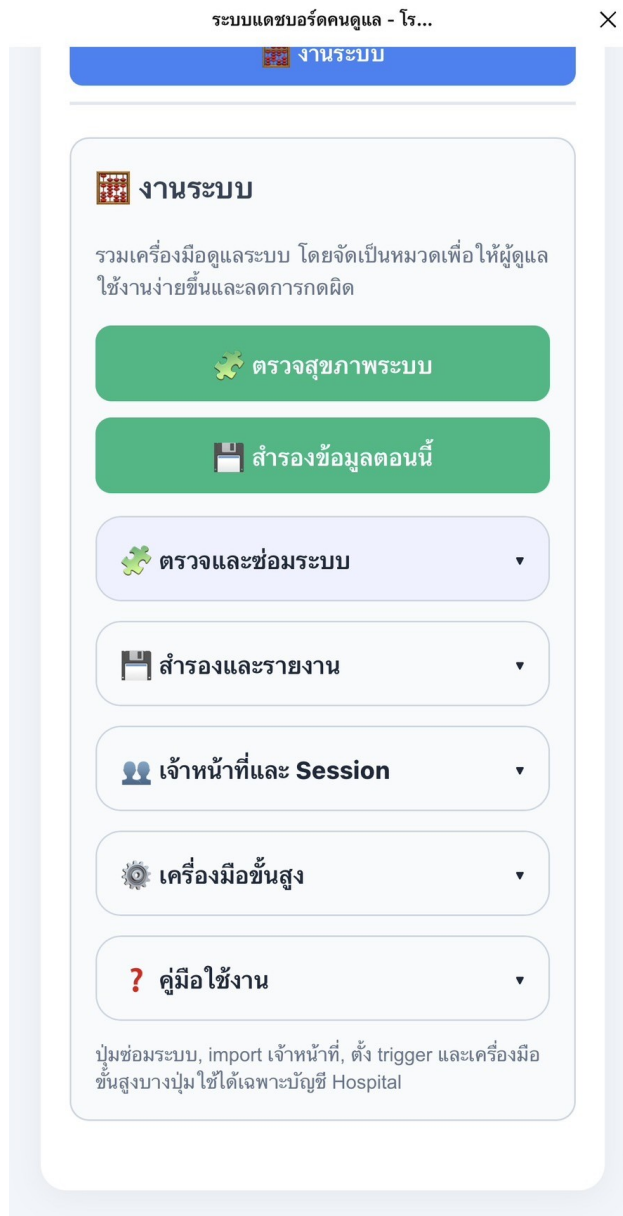
ภาพที่ 46: หน้าส่งข้อเสนอแนะแบบไม่เปิดเผยตัวตน

10.3 งานระบบ

เมนูงานระบบเป็นส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ตรวจสอบความพร้อม สำรองข้อมูล และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



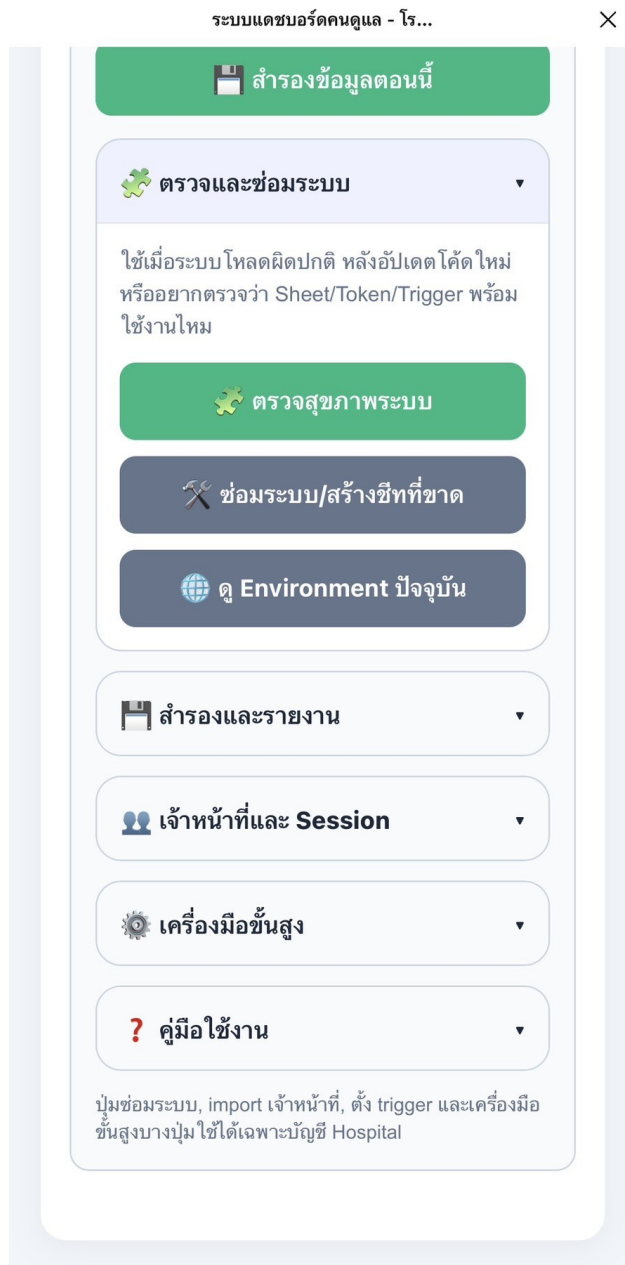
ภาพที่ 39: หน้ารวมงานระบบ



ภาพที่ 40: เมนูงานระบบสำหรับ Hospital

10.4 ตรวจสอบและซ่อมระบบ

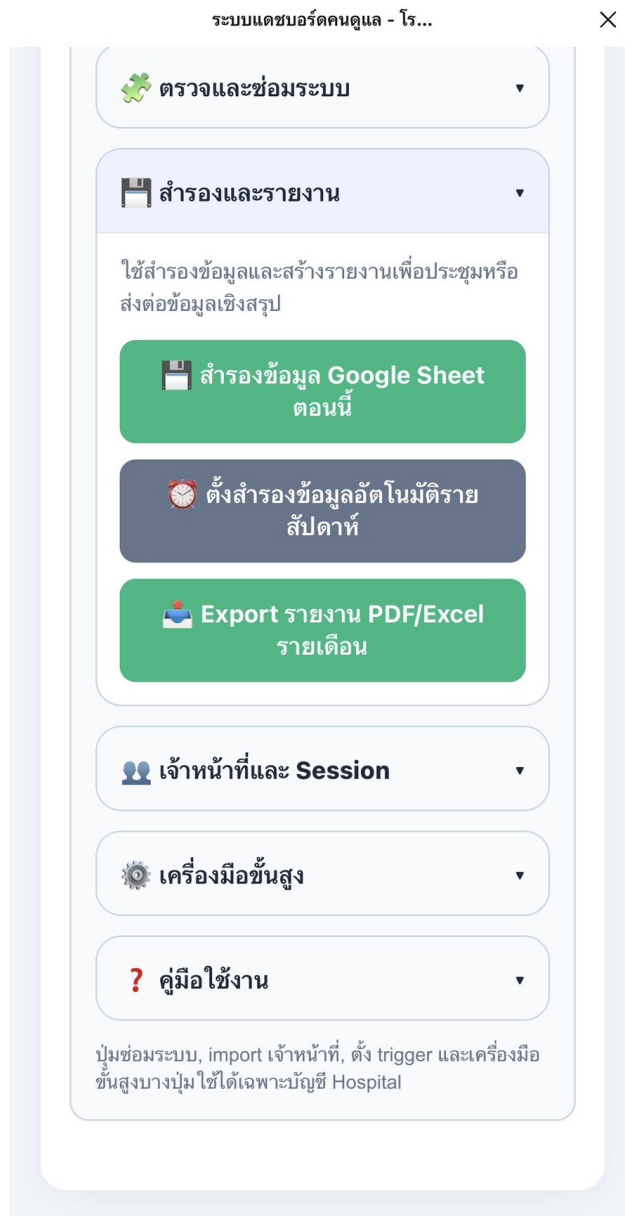
- ตรวจสอบสุขภาพระบบ ใช้ดูว่าระบบพร้อมใช้งานหรือไม่
- ซ่อมระบบ/สร้างซิกที่ขาด ใช้เมื่อซิกหรือข้อมูลบางส่วนหาย
- ดู Environment ปัจจุบัน ใช้ดูว่าระบบกำลังชี้ไปที่ชุดข้อมูลใด



ภาพที่ 41: ตรวจสอบและซ่อมระบบ

10.5 สำรองข้อมูลและรายงาน

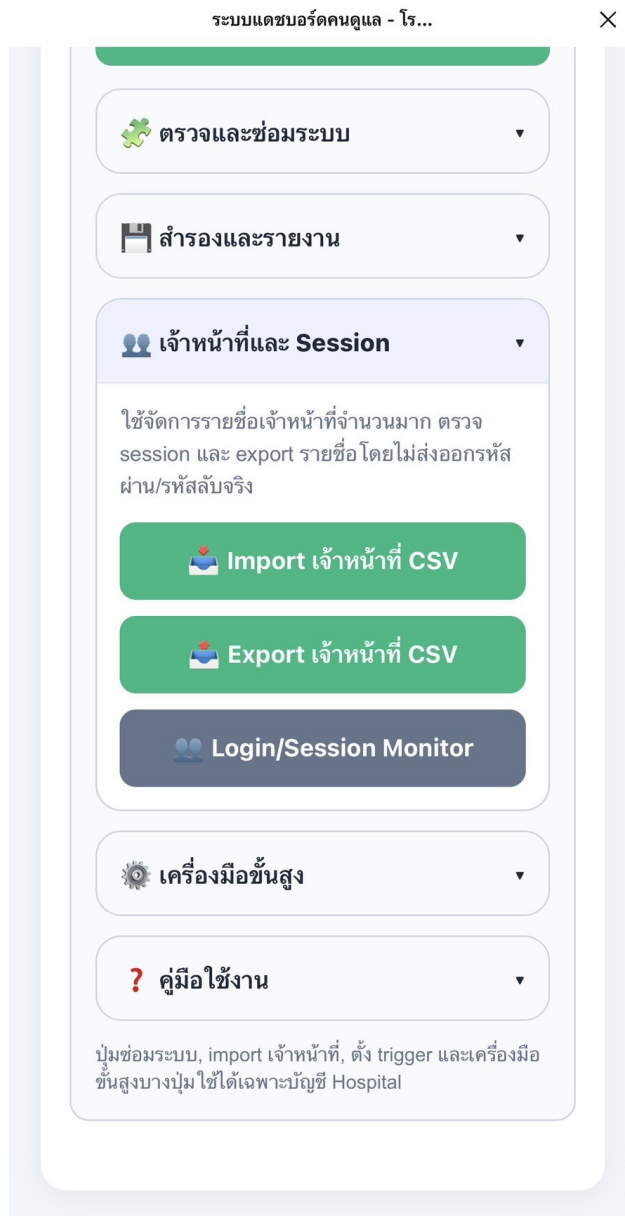
- สำรองข้อมูล Google Sheet ตอนนี้
- ตั้งสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์
- Export รายงาน PDF/Excel รายเดือน



ภาพที่ 42: สำรองข้อมูลและส่งออกรายงาน

10.6 เจ้าหน้าที่และ Session

- Import เจ้าหน้าที่ CSV ใช้นำเข้ารายชื่อเข้าระบบจำนวนมาก
- Export เจ้าหน้าที่ CSV ใช้ส่งออกรายชื่อเจ้าหน้าที่
- Login/Session Monitor ใช้ดูประวัติการเข้าใช้งาน



ภาพที่ 43: Import/Export เจ้าหน้าที่และ Session Monitor

10.7 เครื่องมือขั้นสูง

ควรใช้โดยผู้ดูแลหลักเท่านั้น

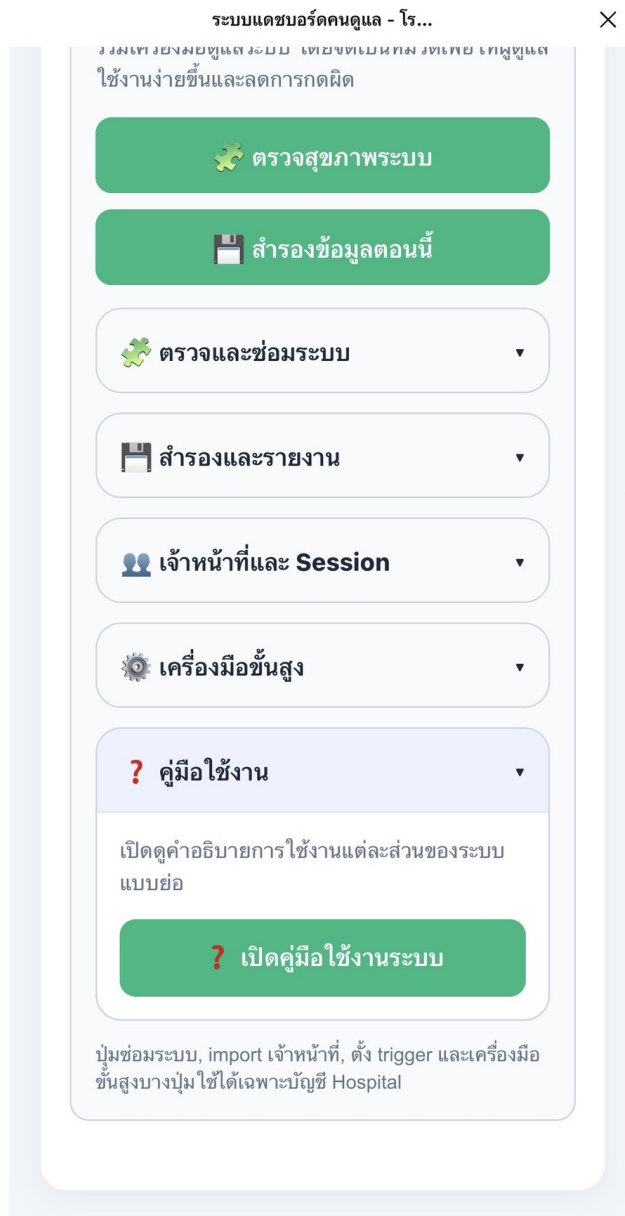
บางปุ่มมีผลต่อระบบจริงหรือข้อมูลจำนวนมาก

ก่อนใช้งาน ควรอ่านคำอธิบายและสำรองข้อมูลก่อน

- ทดสอบแจ้งเตือน Follow-up วันนี้
- สร้าง Staging/Test Copy เพื่อทดสอบ
- ใช้ Staging หรือใช้ Production
- ย้ายเคสปิดงานเกิน 1 ปีเข้าคลัง



ภาพที่ 44: เครื่องมือขั้นสูง



ภาพที่ 45: เปิดคู่มือใช้งานระบบ

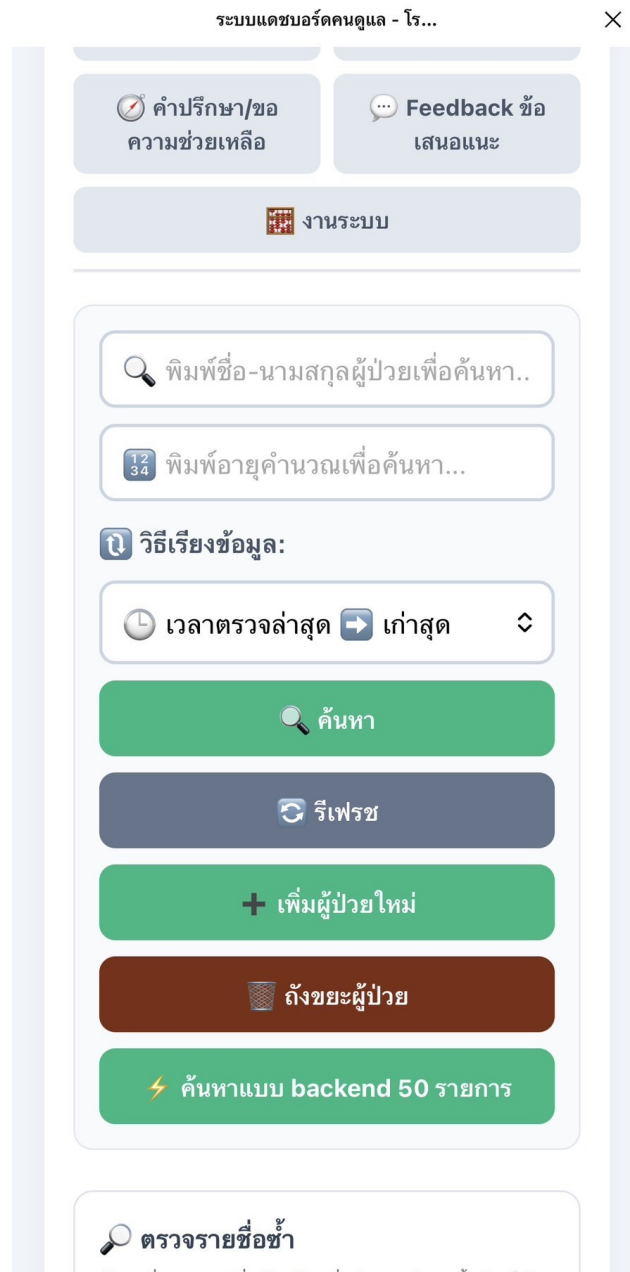
บทที่ 1 1 การลบผู้ป่วย ถึงขยะ และกู้คืนข้อมูล

สิทธิ์สำคัญ

การลบผู้ป่วยทำได้เฉพาะบัญชีบทบาท Hospital เท่านั้น
Admin และ อสม. ไม่ควรมีปุ่มลบผู้ป่วยออกจากระบบ

11.1 ถึงขยะผู้ป่วย

ในหน้าข้อมูลผู้ป่วย จะมีปุ่ม “ถึงขยะผู้ป่วย” สำหรับดูผู้ป่วยที่ถูกลบแบบชั่วคราว



ภาพที่ 47: ปุ่มถังขยะผู้ป่วย

11.2 ลบผู้ป่วยออกจากระบบ

เมื่ออยู่ในหน้ารายละเอียดผู้ป่วย บัญชี Hospital จะเห็นปุ่ม “ลบผู้ป่วยออกจากระบบ” ปุ่มนี้ใช้เมื่อต้องการย้ายผู้ป่วยไปถังขยะ



ภาพที่ 48: ปุ่มลบผู้ป่วยออกจากระบบ

11.3 ขั้นตอนยืนยัน 2 ขั้น

1. กดปุ่ม “ลบผู้ป่วยออกจากระบบ”
2. ขั้นที่ 1 ระบบให้ใส่รหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง
3. ขั้นที่ 2 ระบบถามย้ำอีกครั้ง โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านซ้ำ
4. เมื่อยืนยันแล้ว ข้อมูลจะถูกย้ายไปถังขยะ ไม่ได้หายถาวรทันที

หลังลบแล้วเกิดอะไรขึ้น

ผู้ป่วยจะอยู่ในถังขยะ 30 วัน

ภายใน 30 วันสามารถกู้คืนได้

ถ้าเกิน 30 วัน ระบบสามารถลบถาวรได้ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้

11.4 กู้คืนหรือลบถาวร

การทำงาน	ผลลัพธ์
กู้คืนจากถังขยะ	ผู้ป่วยกลับมาอยู่ในระบบตามเดิม
ลบถาวรจากถังขยะ	ข้อมูลผู้ป่วยจะถูกลบออกถาวร และระบบจะถามยืนยันอีกครั้ง
เกิน 30 วัน	ระบบสามารถลบถาวรได้ตามเงื่อนไขการเก็บรักษาข้อมูล
เพิ่มคนใหม่หลังลบถาวร	ถ้าคนเดิมถูกลบถาวรแล้ว ผู้ป่วยใหม่สามารถใช้ Patient ID ซ้ำได้

ข้อควรระวังมาก

ก่อนลบถาวร ต้องตรวจให้แน่ใจว่าไม่ได้ลบผิดคน

ถ้าลบถาวรแล้วจะกู้กลับจากถังขยะไม่ได้

บทที่ 12 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	วิธีแก้แบบง่าย
เข้าสู่ระบบไม่ได้	ตรวจสอบ Username, Password และเลือกบทบาทให้ถูกต้อง
ระบบค้างตอนตรวจ LINE ID	ปิดหน้าแล้วเปิดใหม่ หรือตรวจอินเทอร์เน็ต
ไม่เห็นหมู่บ้านให้เลือก	เลือกตำบลก่อน แล้วค่อยเลือกหมู่บ้าน
ส่งข้อมูลไม่ได้	บันทึกร่างไว้ในเครื่องก่อน แล้วส่งใหม่เมื่ออินเทอร์เน็ตดีขึ้น
ไม่พบชื่อผู้ป่วย	ลองกดรีเฟรช หรือค้นหาด้วยชื่อบางส่วน
ข้อมูลซ้ำ	ใช้เมนูตรวจรายชื่อซ้ำก่อนรวมผู้ป่วย
Admin ไม่เห็นปุ่มบางอย่าง	ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน บางปุ่มใช้ได้เฉพาะ Hospital
รายงานหรือกราฟไม่อัปเดต	กดอัปเดตข้อมูลรายเดือน/Heatmap หรือรีเฟรชข้อมูล
สงสัยว่าระบบผิดปกติ	ไปทำงานระบบ แล้วกดตรวจสอบสุขภาพระบบ

หลักการใช้งานให้ปลอดภัย

ใช้บัญชีของตนเองเท่านั้น

อย่าเปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสลับบัญชี

ก่อนใช้เครื่องมือขึ้นสูงหรือก่อนลบถาวร ควรสำรองข้อมูลก่อนเสมอ

ภาคผนวก: รายการภาพประกอบทั้งหมด

ส่วนนี้รวบรวมภาพหน้าจอทั้งหมดที่ใช้ประกอบคู่มือ เพื่อให้ผู้ดูแลตรวจสอบหน้าตาระบบได้รวดเร็ว

1. ระบบตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานด้วย LINE ID
2. หน้าเข้าสู่ระบบของ อสม.
3. หน้าหลักของ อสม.
4. กรอกข้อมูลทั่วไปผู้รับการประเมิน
5. ยืนยันการใช้ข้อมูลก่อนเริ่มคัดกรอง
6. แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q+
7. คำแนะนำแบบประเมินความเครียด ST-5
8. ปัจจัยร่วมทางคลินิกและแบบคัดกรอง 10X
9. คำแนะนำ Alcohol / Substance Screening - 10X
10. แจ้งเตือนให้ทำ 9Q เมื่อ 2Q+ มีความเสี่ยง
11. หน้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล
12. ส่วนท้ายของหน้าตรวจสอบและปุ่มส่งข้อมูล
13. รายชื่อในหมู่ของฉัน
14. ร่างออฟไลน์/ข้อมูลรอส่ง
15. หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแลข้อมูล
16. เมนูหลักของแดชบอร์ดผู้ดูแล
17. ตรวจสอบรายชื่อซ้ำก่อนรวมผู้ป่วย
18. หน้ารายละเอียดผู้ป่วยและเก็บข้อมูล
19. ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย
20. ตัวกรองประวัติการประเมิน
21. เปรียบเทียบผลประเมินย้อนหลัง
22. Timeline และ Note ภายในเจ้าหน้าที่
23. มอบหมายงานย่อยและประวัติการแก้ไข
24. แผนติดตามผู้ป่วยและปิดเคส
25. พิมพ์สรุปผู้ป่วยและประวัติเหตุการณ์
26. งานที่ต้องทำวันนี้
27. ศูนย์แจ้งเตือน Admin และปฏิทินติดตาม
28. รายการงานค้าง/งานด่วน
29. ทะเบียนเคสที่ต้องติดตาม
30. สรุปความเสี่ยงปัจจุบันของผู้ป่วย
31. สรุปรายหมู่บ้านและคุณภาพงานรายพื้นที่
32. สรุปเคสรวมทั้งหมด
33. อัปเดตข้อมูลรายเดือน/Heatmap และรายงานประชุมทีม

34. เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าระบบและค้นหาเจ้าหน้าที่
35. ข้อมูลเจ้าหน้าที่และการแก้ไข/ลบ
36. คำปรึกษาและคำขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
37. ตัวกรองคำขอปรึกษาและสรุปจำนวนคำขอ
38. กล้องข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน
39. หน้ารวมงานระบบ
40. เมนูงานระบบสำหรับบทบาท Hospital
41. ตรวจสอบและซ่อมระบบ
42. สำรองข้อมูลและส่งออกรายงาน
43. Import/Export เจ้าหน้าที่และ Login/Session Monitor
44. เครื่องมือขั้นสูงสำหรับผู้ดูแลระบบ
45. เปิดคู่มือใช้งานระบบ
46. ส่งข้อเสนอแนะโดยไม่เปิดเผยตัวตน
47. เครื่องมือค้นหา/เพิ่ม/ถึงขยะผู้ป่วย
48. ปุ่มลบผู้ป่วยออกจากระบบ